ICUで知っておくべき臨床倫理

価値観を聴いてから、医師が提案する

聖路加国際病院 集中治療科

今日持ち帰る3つ

1

選ばせずに、医師から提案する
土台は本人の価値観。強さは状況で変える

2

DNARは心停止時のCPRだけを決める
範囲を明示した指示にし、ほかの治療は別に決める

3

一人で決めず、過程を記録に残す
多職種の検討・共同意思決定・倫理コンサルという手続きに乗せる

はじめに

倫理は、
毎日の判断の中にある

特別な症例のときだけの話ではない

聖路加国際病院 集中治療科

この聞き方、していませんか

「心臓マッサージは希望しますか」

価値観を聴く前に、処置の希望を聞く

「DNARなので挿管はしません」

心停止前の治療まで、自動的に控える

「ご家族で決めてください」

決断の重さを、家族に預けてしまう

どれも悪意はない。**聴く順番と、DNARの範囲**がずれている

第 1 章

01

言葉と原則

選ばせずに提案し、強さを変える

同じ言葉を、同じ意味で使う

用語	定義・使い方	避ける言い方
DNAR	心停止時にCPRを試みない指示。 **心停止時だけ**有効	「急変時DNR」
差し控え／終了	始めない／やめる。倫理的に同等	「治療中止」
終末期	4学会GLは定義しない。ゴールから判断する	「終末期なので」
推定意思	本人ならどう考えるか。家族の 希望と区別する	「家族がDNARを希望」
BSC・延命治療	使わない。何をするかを具体的に書く	「BSCで」

出典：4学会合同ガイドライン（2026）、日本集中治療医学会 DNAR勧告（2017）、日本救急医学会 用語の統一概念（2025）

中心原則：選ばせずに、医師から提案する

相手に選ばせず、医師から提案する。

ただし、状況に応じて提案の強さを変える。

1
病状を伝える

→

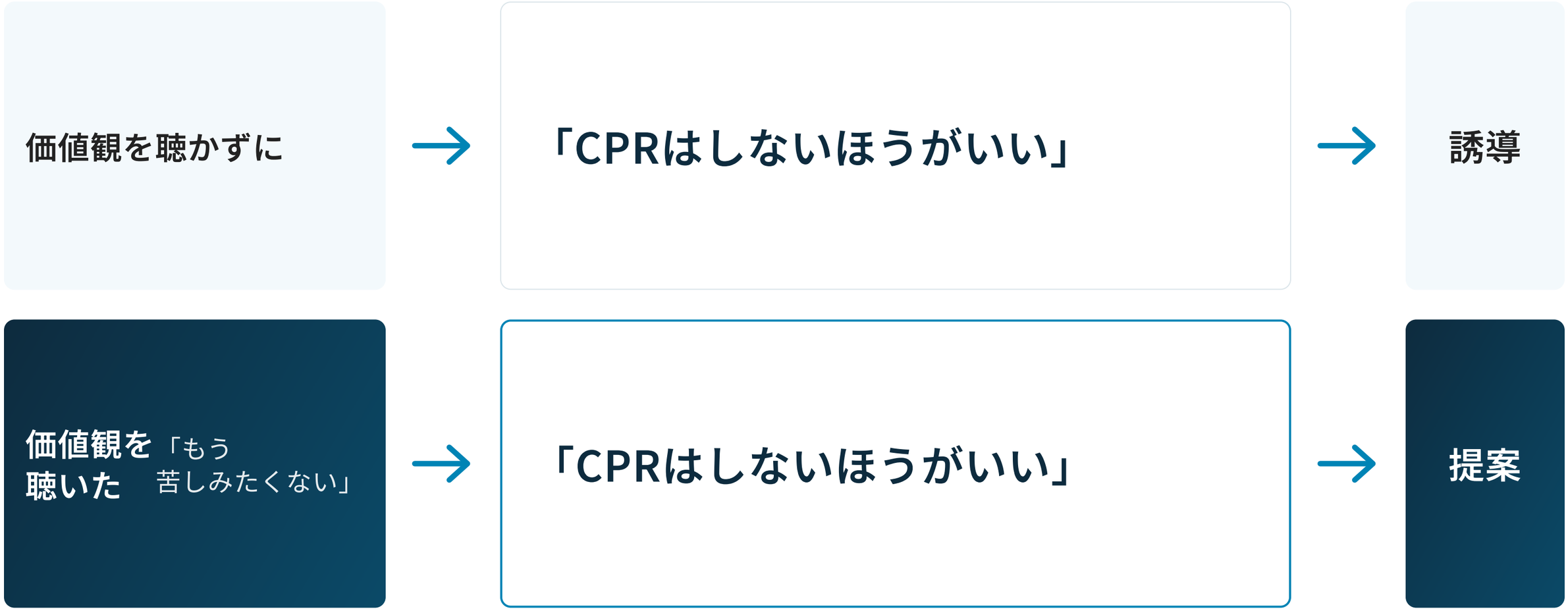
2
価値観を聴く

→

3
専門家として
推奨する

出典：Lu E, Mayo Clin Proc 2020（3ステージ）、AHA 2025 倫理編

提案と誘導を分けるのは、価値観の土台



同じ言葉でも、順番で意味が変わる。提案は**価値観を医療行為に翻訳**すること

出典：Lu E, Mayo Clin Proc 2020

中心原則

決める重さは、医療者が引き受ける

「どうしますか」は、決断を丸投げしている

聖路加国際病院 集中治療科

提案の強さは、5段階

●●●●●	informed assent	「○○はしません」	無益が明らかで、 価値観もはっきり
●●●●○	informed nondissent	「反対があれば、おっしゃってください」	拒否権を明示して残す
●●●○○	推奨して意見を求める	「しないほうがいいと思います」	推奨ははっきり、 決定は一緒に
●●○○○	やや弱い推奨	「おすすめしません」	医学的な見込みに幅が あるとき
●○○○○	使わない	「○○はどうしますか」	ゴールに 寄与しないなら、 丸投げになる

強い：医療者が重さを引き受ける　　弱い：決断を相手に預ける

出典：Curtis JAMA 2020（informed assent）、AHA 2025 倫理編（informed nondissent）

強さを選ぶ、3つの要素

1

医学的な確かさ
利益がないことが、どこまで明らかか

2

価値観の明確さ
本人が何を大切にするかが、聴けているか

3

委ねたい気持ち
家族が決定を医療者に委ねたいか。**強い形の前に確かめる**

そろわなければ強さを下げる。価値観が聴けていなければ、提案の前に聴き直す

出典：AHA 2025 倫理編、Curtis JAMA 2020

第 2 章

02

枠組みと決める人

4原則・4分割法・意思決定能力

4原則は、ぶつかる価値に名前をつける

自律尊重
本人が自己決定する権利

例：本人が挿管を拒む、事前指示がある

善行
本人に最大の利益をもたらす義務

例：見込みの不確かな治療を始めるか

無危害
利益のない治療で害を与えない義務

例：苦痛を伴うだけの処置、無益なCPR

公正
すべての患者を公平に扱う義務

例：ベッドの配分、障害や年齢による無自覚な差

**「全部やって」は、家族の希望（自律の代理）と
無危害がぶつかっている、と言い換えるだけで議論が進む**

出典：FCCS（倫理の章）

4分割法で、症例をもれなく並べる

医学的適応
診断と予後、治療の目標、成功の可能性、
失敗したときの対応

患者の意向
本人の希望、意思決定能力、事前の意思表示、
代理は誰がどの基準で

QOL
元の生活に戻る可能性、評価者のバイアス、
緩和ケアの予定

周囲の状況
家族、医療者側の問題、経済・宗教・文化、
資源、法律

4つの窓を全部埋めてから議論する。埋まらない窓が、次に集める情報

出典：Jonsen の4分割表。4学会GLの「臨床倫理的検討の4つの側面」も同じ骨格

意思決定能力は、決定ごとに評価する

① 選択を伝えられる

② 理解する

③ 自分のこととして認識する

④ 比較して考えられる

- 全か無かではない。**医学的助言に反する選択**だけでは能力欠如の根拠にならない
- 鎮静・せん妄で能力は時間で動く。清明な時間に合わせる
- 代理は「家族の希望」ではなく「**本人ならどう考えるか**」

出典：Ganzini JAMDA 2004、4学会合同ガイドライン（2026）

第 3 章

03

ACPと価値観

病状 → 価値観 → 推奨の順に

ACP

価値観を先に聴き、治療の話は最後に

選択肢から始めると、生死の二択になる

聖路加国際病院 集中治療科

病状 → 価値観 → 推奨の3段で話す

Stage 1

病状を伝える

予後をはっきりと。
医療者が主

→

Stage 2

価値観を聴く

一番の気がかり、大切にしてきたこと。**本人・家族が主**

→

Stage 3

推奨する

価値観を医療行為に翻訳して提案。
医療者が主

> **いちばん多い失敗は、Stage 2 を飛ばして Stage 3 の選択を迫ること**

出典：Lu E, Mayo Clin Proc 2020、Elwyn BMJ 2010

ACPは書類ではなく、価値観の共有

48%

事前指示書が効く7条件が、それぞれ**90%**で
そろっても、全部そろう確率（0.9の7乗）

- 書類を作ると「もう話さなくてよい」となり、家族が思いを聞く機会を失うこともある
- 根幹は、本人が価値観を言えること
- 代理人を1人決めるより、**多くの家族と共有**しておく

ACPは、イベントではなく繰り返すプロセス（厚労省GL 2018）

出典：厚労省GL 2018、Auriemma JAMA Intern Med 2022、『あなたのACPはなぜうまくいかないのか？』2024

上限と下限を探る問い

順	尋ねること（要旨）	ねらい
① **楽しみ**	いま楽しみにしていること	上限を探る。答えやすい
② **生きがい**	大切にしていること	さらに深く聞く
③ **気がかり**	**悪くなったとき**の一番の気がかり	下限に向かう
④ **許容できない状態**	こうなったら生きていたくない状態	ICUの場面では使わず、③までで探る

出典：4学会合同ガイドライン 緩和ケア別編、『あなたのACPはなぜうまくいかないのか？』（2024）

第 4 章

04

DNAR

範囲は心停止時だけ。事前に決めておく

DNAR

DNARは、
心停止時のCPRだけを決める

ほかの治療は、別に話し合って決める

聖路加国際病院 集中治療科

DNARで決まること、決まらないこと

決まること	心停止時に、胸骨圧迫・除細動・気管挿管などの**蘇生を試みない**
決まらないこと	心停止前の挿管・人工呼吸・昇圧薬・血液浄化・ICU入室。目標と価値観に照らして**一つずつ**決める
必ず行うこと	抗菌薬・酸素・非侵襲的換気・鎮痛鎮静・補液。DNARの有無にかかわらない

「心停止」を「急変時」にすり替えない

出典：日本集中治療医学会 DNAR勧告（2017）、日本救急医学会 用語の統一概念（2025）

してはいけない運用が、3つある

一律・便宜的なDNAR
入院時に一律に設定する、業務効率や急変対応の簡略化のために設定する

部分的DNAR
「胸骨圧迫はするが挿管はしない」。不完全な蘇生では救命できない

スローコード
意図して不完全に行う形だけの蘇生。患者への危害で、家族への欺瞞

4学会GLは、適用範囲が明確なDNARを求めている

出典：4学会合同ガイドライン Q37・Q39、日本集中治療医学会 DNAR勧告（2017）、AHA 2025 倫理編

「原疾患の心停止だけ」は成り立たない

反論①

心停止の原因は、その場では**分からない**。発見するのは多くが看護師で、原因の判断を求めるのは無理がある

反論②

DNARを考える根拠の多くは「その人にCPRの利益がない」という見込み。原因が分からなくても**見込みは変わらない**

文書の根拠

原疾患に限ると定めた学会文書は見当たらない。別の原因での心停止は**事前に話し合え**とあるだけ

出典：日本集中治療医学会 委員会報告（2016）、AHA 2025 倫理編

フレイルは材料であって、結論ではない

医学の問い

蘇生がうまくいくか

- フレイルでCPR後死亡 OR 3.56（7研究）
- CFS 4超で生存退院 0／90例中
- CFSが高いほど神経学的転帰が悪い（日本）

価値の問い

この人にとって蘇生が最善か

- フレイルは答えない
- 年齢を唯一の決定因子にしない
- 価値観を引き出す方法がSDM

閾値は研究ごとに違い、一律の線は引けない

出典：Hamlyn Resusc Plus 2022、Ibitoye Age Ageing 2021、Yamamoto Ann Emerg Med 2023、AHA 2025 倫理編

4学会GLは、終末期を定義せず手続きで決める

1

終末期を定義しない
例示が「線」として読まれ、その外で考えが止まった反省から

2

2本柱で決める
多職種の臨床倫理的検討と、本人・家族等との共同意思決定

3

4つの側面
医学的側面・患者の意向・QOL・周囲の状況。フレイルは「医学的側面」の一つ

4

範囲の明確なDNAR
入院時に一律に取るDNARを否定する

出典：4学会合同ガイドライン（2026）

入院時は、推定意思の確認にとどめる

入口	蘇生の可否は聞かない。「**何か伺っていますか**」と、大事にしてきたこと・望まないことを聴く
指示簿	「暫定フルコード（状況により随時検討）」と書き、話し合いの**進捗**を残す
経過の中で	悪化の兆し・反応が乏しい・家族の問いで話し合い、**範囲の明確なDNAR**に落とす

> **一律の確認は、全例フルコードという構造への防衛反応。直すのは記録の形**

出典：厚労省プロセスGL（2018）、4学会GL Q&A（2026）

価値の判断は事前に、現場では指示に従う

看護師（発見者）

- その場で本人の価値観に立ち返らなくてよい
- 範囲が明確な指示に従う
- 範囲が曖昧で迷ったら、**蘇生を始めながら確認**

医師

- 事前の話し合いで、価値観を聴いてから推奨する
- はい／いいえで選ばせない
- 結果を**範囲の明確な指示**にしておく

出典：AHA 2025 倫理編

informed nondissent ―― 拒否権を残す

言い方の例（要旨）

「伺ったお考えからすると、心臓が止まったときの蘇生は行わない方針がよいと考えます。」

「反対があればおっしゃってください。なければ、この方針で進めます。」

家族に**決断の重荷**を
負わせない

医療者が一方的に
決めるのでもない

使う前に、決定を
委ねたいかを確かめる

出典：AHA 2025 倫理編

窒息と医原性の心停止は、どう扱うか

窒息の苦しさ	異物除去や吸引はCPRではない。DNARと無関係に行う
窒息後の心停止	CPRをするかは、原因ではなく**事前に合意した範囲**で決まる
処置に伴う心停止	可逆的で、処置への同意に回復が含まれうる。処置中にDNARを一時変更・解除するかを**事前に決める**

DNARのある80歳が内視鏡中の喉頭痙攣で心停止した場面で、医師の83.4%が「CPRをする」と回答（学会の調査）

出典：日本集中治療医学会 委員会報告（2016）

DNARの指示の書き方 —— 実装の一案

1

心停止時は原因を問わずCPRを行わない
発見者にその場で原因を判断させないため

2

窒息による心停止も含む
DNARを考える患者では十分に起こりうるため

3

処置に伴う心停止は、事前に扱いを決める
処置中に一時変更・解除するか

4

望む状態に戻れないと分かれば、終了を検討
始めたらやめられない、を外す

4学会GLが求めるのは「範囲を明確に」まで。これは<u>GLのルールではなく実装の一案</u>

一般論としての提案。施設ごとに倫理委員会などで検討して決める

TLTとACPは、車の両輪

ACP（事前の対話）
価値観を共有し、範囲の
明確な指示にしておく

TLT（始めて確かめる）
期間と評価項目を決めて
試し、結果で継続・
終了を決める

- 目標・再評価の日と指標・価値観との結びつきを、**始める前に**決める
- 期限で自動的に終了も延長もしない
- 「迷ったらとりあえず始める」の**免罪符にしない**

出典：4学会合同ガイドライン（2026）

第 5 章

05

差し控え・終了と家族

手順で決め、重荷を負わせない

2本柱で検討し、3つの対応から選ぶ

柱1 チームの臨床倫理的検討

4つの側面をもれなく。関わる診療科・多職種・かかりつけ医まで、全員に発言の機会を

柱2 本人・家族等との共同意思決定

厚労省プロセスガイドラインに沿う。価値観を聴いてから推奨する

差し控え
始めない

終了
症状緩和のみ、または一部

TLT
期限付きで試す

出典：4学会合同ガイドライン（2026）。どれでも心停止時のCPRは行わず、症状緩和は続ける

差し控えと終了は、倫理的に同等

89.7%
欧州22 ICUで、治療制限を伴う死（2015〜16年）

34.9%
差し控えのあと、生存して退院

98%
終了のあと、24時間以内に死亡

倫理的には同等。「やめられないから始めない」をしない。臨床経過は別物なので記録で書き分ける

出典：Ethicus-2（Sprung JAMA 2019）、4学会合同ガイドライン（2026）

家族との対話

知らせの直後に、決めさせない

混乱や沈黙は、生理的な過負荷のサイン

聖路加国際病院 集中治療科

決定の重荷を、家族に負わせない

知らせの直後	見出しを1文で伝え、**間を置く**。「わかりましたか」ではなく受け取ったことを話してもらう
予後を聞かれたら	「わかりません」で済ませず、数日〜数週など**時間の単位**で伝え、沈黙を置く
決めるとき	「家族が決めた」ではなく「医学的な結論を家族と確認した」と表す
対立したら	課題 → プロセス → 関係の**3層**で見立てる。「困った家族」と呼ぶ前に

出典：Rusinova ICM 2026、Choi Crit Care 2026、Jabaley Crit Care 2026 ほか

スローコードは、家族への配慮ではない

82.4%
「欺瞞」と判断した倫理文献

67.6%
「患者への害」と判断

61.8%
無益なCPRは断ってよい

- 短時間だけのCPR（time-limited code）も、倫理的な妥協にならない
- 解決は、**心停止の前に**処置の単位で話すこと

出典：Fontenot CCM 2026、Wasserman Crit Care 2026

第 6 章

06

支える・記録する

医療者を守り、過程を残す

モラルディストレスは、組織の課題

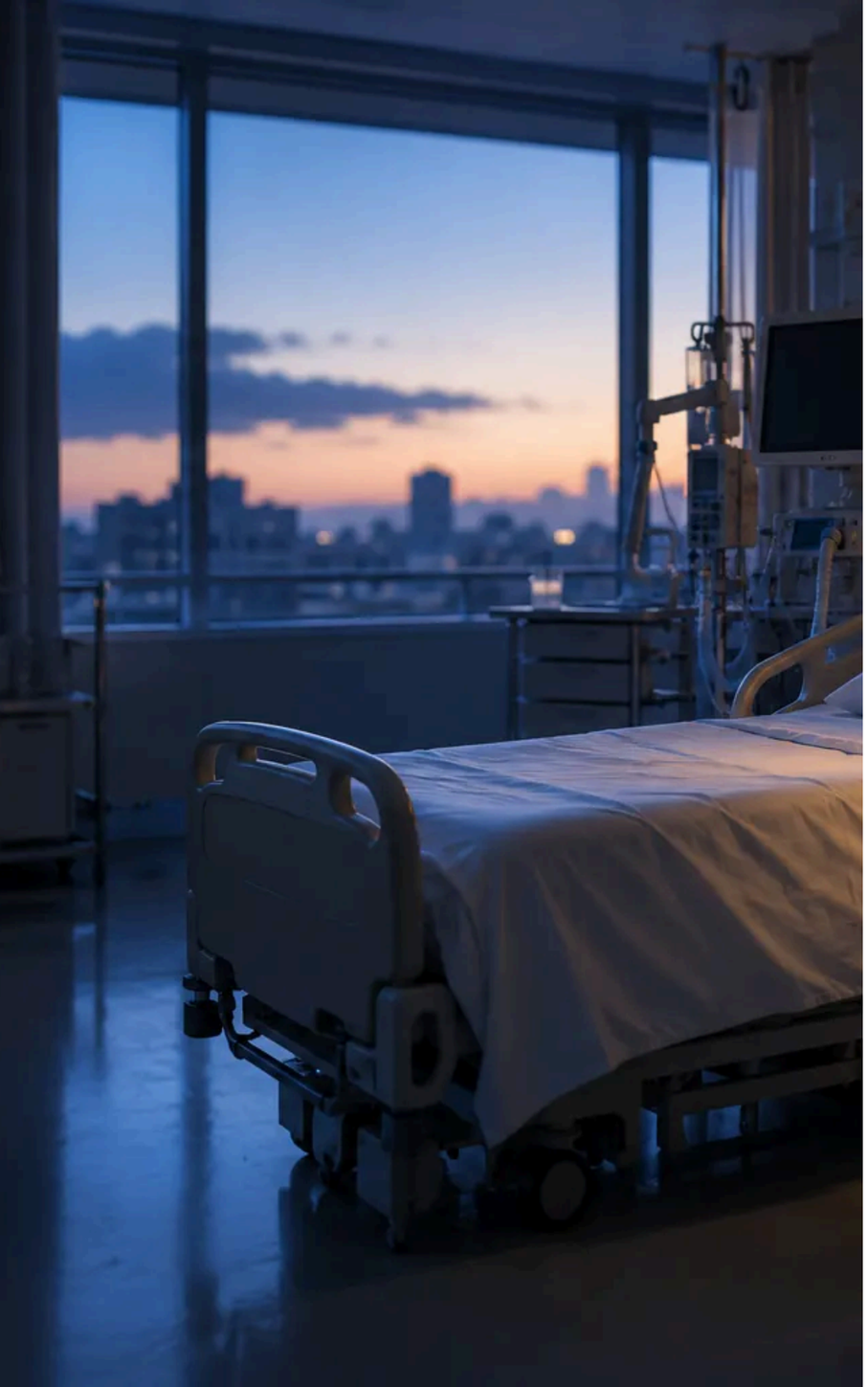
26%

「不適切な治療をしている」と感じていた医療者（オランダ47 ICU・1,058人）

複数人が一致した患者の6か月死亡 aOR 3.86

- 違和感は**予後のシグナル**。ゴールを見直すきっかけにする
- 治療を足す手続きはあるのに、**減らす手続きがない**
- 先に変えるのは権限と手続き。デブリーフィングは緩和であって予防ではない

出典：PICNL-ICU（CCM 2026）、Brender JAMA Netw Open 2025



死の判定と臓器提供は、手順を分ける

死の判定	確かめているのは「戻せない」ではなく「**もう戻さない**」という決定（permanence）
順序	終了の判断が先、臓器提供の提示は後。提供の可能性で終了を決めない
家族	死亡告知と提供の依頼を**同じ面談に入れない**
脳死	「臓器を支える治療」と言い換え、判定への立ち会いを選べるようにする

出典：Le Dorze・Choi Crit Care 2026、4学会GL、Wu JAMA 2026

年齢や障害で推し量らず、本人に尋ねる

1. 「普段使っているコミュニケーション手段は」
2. 「入院前は、何ができる状態でしたか」
3. 「この推奨は、**障害がなかったとしても同じ**ですか」

障害や医療機器の使用だけを理由に、
差し控え・終了を検討しない（4学会GL）

出典：Taccone ICM 2023、Albrecht 1999、4学会GL 2026

カルテ記載

結論だけでなく、範囲と過程を残す

DNARの有無だけでは、夜勤に伝わらない

聖路加国際病院 集中治療科

文例1：DNAR指示は、範囲で書く

【コードステータス】DNAR（心停止時に心肺蘇生を試みない）

- 適用範囲：心停止の原因を問わず、胸骨圧迫・除細動・気管挿管・蘇生薬投与を行わない。窒息による心停止を含む。
- 例外：**［内視鏡／CV挿入など］**処置に伴う心停止の扱いは処置前に確認
- DNARを理由に控えない治療：酸素、輸液、抗菌薬、昇圧薬、**［NIV］**
- 心停止前の治療（別に決定）：挿管**［行う／行わない／TLT］**、透析**［…］**
- 再評価：**［病状が変化したとき／○月○日／処置の前］**

［ ］は症例ごとに書き換える。施設の様式に合わせて直す

一般論としての文例。4学会GLが求める記録項目に沿う

文例2：面談記録は、過程を残す

1．病状の説明
　見通しは［数日〜数週］の単位で
　家族等の理解：「［家族の言葉］」
2．本人の価値観・意向
　「［本人の言葉。できるだけ逐語］」
　推定意思の根拠：［以前の会話など］
　→ ゴール：［苦痛を最小限に…］

3．推奨と合意
　CPRは行わないことを推奨した
　提案の形：［assent／nondissent］
　委ねたい意向を［確認した］
　反応：［異議なし／保留（理由）］
4．4つの側面の検討
5．決定・保留・再評価日

一般論としての文例。参加者（本人・家族等・医師・看護師・ほか）も必ず書く

文例3・4：TLTと、本人の意思によるDNAR

文例3 TLT

目的：［会話できる状態に戻ること］
治療：［人工呼吸／CRRT］
期間：［7日間］ 再評価 ［○月○日］
評価項目：［酸素化・昇圧薬・意識］
改善しないとき：［終了を含め
ゴールに沿って話し合う］

文例4 本人の意思によるDNAR

本人 ［意思決定能力あり：
理解・認識・論理的思考・選択の表明］
「［本人の言葉］」
本人の価値観に基づく選択として
心停止時のCPRを行わない
家族等 ［氏名］ と共有 ［済／未］

一般論としての文例。終末期でなくても、本人には生命維持治療を選ぶ権利がある（4学会GL）

記録で避けること

「急変時DNR」「DNR取得」
範囲が曖昧で、治療全般を
控える読み方を招く

「家族がDNARを希望」だけ
価値観・推定意思の
根拠・推奨がなく、何を
合意したか残らない

チェック欄だけ
有無だけでは、範囲と理由が
伝わらない

DNAR指示の記録は9割、協議の過程の記録は7割（学会の調査）

出典：日本集中治療医学会 委員会報告（2016）、4学会合同ガイドライン（2026）

明日から変える3つ

1

「どうしますか」を、推奨に変える
価値観を聴いてから。強さは3つの要素で選ぶ

2

DNARを「心停止時は原因を問わず」と範囲で書く
心停止前の治療は別に決める

3

面談記録に、本人の言葉と推奨の形を残す
結論だけでなく、過程を残す

ご清聴ありがとうございました

次の面談で、選ばせずに提案してみてください

聖路加国際病院 集中治療科

主な出典

- 日本集中治療医学会ほか4学会. 救急・集中治療における生命維持治療の終了／差し控えに関する4学会合同ガイドライン. 2026
- 日本集中治療医学会. DNAR指示のあり方についての勧告. 2017／委員会報告. 2016
- 日本救急医学会. 高齢者救急に関する用語の統一概念. 2025
- 厚生労働省. 人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン. 2018
- Elmer J, et al. Part 3: Ethics: 2025 AHA Guidelines for CPR and ECC. Circulation 2025
- Curtis JR, et al. JAMA 2020／Lu E, et al. Mayo Clin Proc 2020／Elwyn G, et al. BMJ 2010
- Hamlyn J, et al. Resusc Plus 2022／Ibitoye SE, et al. Age Ageing 2021／Yamamoto R, et al. Ann Emerg Med 2023
- Fontenot T, et al. CCM 2026／PICNL-ICU. CCM 2026／Sprung CL, et al. JAMA 2019
- 『あなたのACPはなぜうまくいかないのか？』メジカルビュー社 2024